

全程康复护理干预对阿尔茨海默病的疗效观察

江皋轩 李明秋 黄海华 柴振芳 吴爱莲 张国胜

【摘要】 目的 观察全程康复护理干预对阿尔茨海默病(AD)的临床疗效。**方法** 选择 96 例 AD 患者,随机分为对照组 48 例和研究组 48 例。对照组运用脑复康、多奈哌齐等进行常规治疗和常规护理,研究组在上述常规治疗的基础上进行全程康复护理干预,内容包括认知干预、记忆干预、行为干预、心理干预、安全干预、用药指导、社区-家庭护理干预等。以简易智能状态检查量表(MMSE)、AD 评估量表认知分量表(ADAS-cog)、日常生活能力量表(ADL)、神经精神科问卷(NPI)、总体衰退量表(GDS)等评分作为主要评价指标,比较 2 组患者在干预前及干预 1 年后认知能力、精神状态、日常生活能力的改善情况。**结果** 全程康复护理干预 1 年后,研究组患者 MMSE、ADAS-cog、ADL、NPI、GDS 的评分明显优于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 全程康复护理干预可明显改善 AD 患者的认知能力、日常生活能力和精神行为症状。

【关键词】 阿尔茨海默病;全程康复护理;生活质量

The curative effect of whole course rehabilitation nursing intervention on mild-to-moderate Alzheimer's disease patients JIANG Gao-xuan, LI Ming-qiu, et al. Department of Gerontology, General Hospital of Jiang-han Oil Field, Qianjiang 433121, China

【Abstract】 Objective To evaluate the curative effect of whole course rehabilitation nursing intervention on mild-to-moderate Alzheimer's disease (AD). **Methods** A total of 96 cases with AD were randomly divided into a control group and a study group. The control group receive conventional therapy with Piracetam and Donepezil, while the study group, on the basis of conventional therapy, were administrated whole course rehabilitation nursing intervention including cognitive intervention, memory intervention, behavior intervention, psychological intervention, safety intervention, community family nursing intervention, etc. The improvement of recognition ability, mental state, activities of daily life were graded by mini-mental state examination (MMSE), Alzheimer's disease assessment scale-cog (ADAS-cog), activity of daily living (ADL), neuropsychiatric inventory (NPI), global deterioration scale (GDS). The scores were compared between the groups before the nursing intervention and one year after the nursing intervention respectively. **Results** Compared with those of the control group, the scores of MMSE, ADAS-cog, ADL, NPI, GDS in the study group present obviously better figures which were more statistically significant after whole course rehabilitation nursing intervention one year ($P < 0.05$). **Conclusion** Whole course rehabilitation nursing intervention can improve the cognitive ability, activities of daily life and spirit behavior symptoms of patients with mild to moderate AD.

【Key words】 Alzheimer's disease; Whole course rehabilitation nursing intervention; Living quality

阿尔茨海默病(AD)是一种进行性加重的神经变性疾病,如果不进行有效的治疗和康复护理干预,以记忆为主的多种认知功能和日常行为能力将呈进行性衰退^[1]。目前临床缺乏特异治疗手段,因此有效的护理干预对延缓 AD 的进程,提高患者生活质量尤其重要^[2]。目前有关 AD 的护理模式繁多,但尚未建立科学有效的护理干预 AD 的体系^[3],因此,我院进行了多年探索,建立了系统的 AD 患者全程康复护理干预体系,并取得了满意的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2006 年 1 月至 2011 年 7 月入住我院托老康复中心的 AD 患者 96 例,随机分为对照组 48 例,男 22 例,女 26 例,平均年龄(71.33 ± 3.49)岁,平均病程(26.96 ± 10.03)个月,轻度 21 例,中度 27 例;研究组 48 例,男 20 例,

女 28 例,平均年龄(71.49 ± 3.75)岁,平均病程(27.69 ± 8.61)个月,轻度 19 例,中度 29 例。2 组患者在年龄、性别、病程、简易智能状态检查(MMSE)、AD 评估量表认知分量表(ADAS-cog)、日常生活能力(ADL)、神经精神科问卷(NPI)、总体衰退量表(GDS)评分具有可比性(表 1)。所有患者诊断符合美国精神障碍《诊断与统计手册》第四次修订版(DSM-IV)和美国神经学会、语言障碍和卒中-老年性痴呆、相关疾病学会(NINCDS/ADRD)制定的 AD 诊断标准^[4]。

入选标准:符合 AD 的诊断标准;以记忆障碍或遗忘为主诉,病程>6 个月;头颅 CT 或 MRI 扫描支持 AD 诊断;Hachinski 缺血量表(HIS)评分<4 分;年龄<80 岁,无严重心、肝、肾等重要脏器的器质性病变;无抑郁症病史;具有一定经济实力完成治疗,并签订知情同意书。**排除标准:**重度痴呆;意识障碍;3 个月内接受过抗精神病药物治疗;经诊断为其他原因的痴呆;未按规定方案治疗者。

1.2 方法

作者单位:433121 潜江,江汉油田总医院老年病科

通讯作者:黄海华 E-mail: huanghaihua@263.net

1.2.1 治疗方法 2 组患者均按医嘱进行脑复康,多奈哌齐等药物治疗,康复护理干预期间药物剂量不变。

1.2.2 全程康复护理干预方法 2 组患者均按医嘱进行内科常规治疗和护理。研究组于入院第 2 天开始,根据本院编制的《老年痴呆全程康复护理规程》进行全程康复护理干预。内容包括:①组织与管理:成立由专家、责任医生、责任护士、护工组成的 AD 全程康复护理指导小组,小组成员负责制订 AD 患者个性化全程康复护理计划,并负责组织实施。②健康教育:针对 AD 患者的健康问题和照顾者对健康教育知识的需求,每周进行相关老年性痴呆健康教育。③认知干预:干预患者分析、综合、推理、判断和计算的能力,主要方法为 3R 护理^[8]:即 Reminiscence(回忆往事)、Reality(现实定向)和 Remotivation(记忆再激发)。主要包括计算能力训练(如计算家庭每月食品费、水电费、电话费、医疗费等开支,再算半年和全年费用等)、数字排列训练(如扑克牌打乱后再让患者按顺序排列等)、分类法训练(如给患者一张写有 40 种物品名称的清单,让患者进行归类)等,每天训练三次。④记忆干预:每天帮助患者记忆住所的环境、周围的人和物,最近进行的一些活动等。⑤语言训练:要求患者叙述每天周围发生的事件、家庭情况、新闻故事,让患者多交流,每天至少三次,防止出现语言障碍。⑥行为干预:根据患者功能障碍情况,从日常生活的穿衣、饮食、住房、用厕、出行等开始,并从患者的日常生活、文体活动或一些轻的劳动过程中选出一些能使患者感兴趣并有助于恢复功能和技能的活动,并按要求进行训练,帮助维持或恢复功能。根据患者状况确定训练时间。⑦心理干预:每天根据患者出现焦虑和抑郁等负性情绪的特点,采用安慰、鼓

励、暗示以及听音乐、看幽默剧等方法对患者及照顾者进行心理干预。同时鼓励患者与家人、亲友交往,从思想上、情感上尽可能沟通,以减少患者的内心痛苦、孤独感、失望感、自罪自责感。⑧用药指导:指导和督促患者按医嘱科学用药。⑨安全干预:营造一个舒适、安全的住院环境及家居环境,防止出现并发症和各种意外事故(如摔倒、骨折、走失、火灾、自杀自残等)发生。⑩社区-家庭护理干预:患者在出院后,进行家庭跟踪随访护理干预,每月为患者及照顾者进行讲课,每 2 周上门随访 1 次,每周电话随访 1 次,了解患者的康复治疗情况,提出相关指导意见。

1.2.3 评估方法 所有患者由专业医护人员分别使用 MMSE、ADAS-cog、ADL、NPI、GDS 等量表于治疗前及全程康复护理干预 1 年后对患者进行相关指标的测定。

1.3 统计学方法 应用 SPSS 17.0 统计软件进行数据分析,检测结果用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示。计量资料采用 *t* 检验,计数资料采用 χ^2 检验。组间比较采用 *t* 检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究组组内比较 与干预前比较,研究组 MMSE、ADAS-cog、ADL、NPI、GDS 等指标的评分,差异均具有统计学意义($P < 0.01$),见表 2。

2.2 研究组与对照组比较 在全程康复护理干预 1 年后,与对照组比较,研究组 MMSE($P = 0.028$)、ADAS-cog($P = 0.030$)、ADL($P = 0.019$)、NPI($P = 0.022$)、GDS($P = 0.033$),差异均具有统计学意义($P < 0.05$),见表 2。

表 1 2 组一般资料比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	病程	年龄	MMSE	ADAS-cog	ADL	NPI	GDS
对照组	48	26.96 ± 10.03	71.33 ± 3.49	18.52 ± 3.40	28.96 ± 6.80	34.96 ± 6.80	13.52 ± 4.74	3.85 ± 0.77
研究组	48	27.69 ± 8.61	71.94 ± 3.75	18.31 ± 3.63	29.38 ± 7.23	35.46 ± 7.46	13.90 ± 4.04	3.88 ± 0.82
<i>P</i> 值		0.703	0.416	0.772	0.771	0.732	0.677	0.898

表 2 2 组患者干预前后 MMSE、ADAS-cog、ADL、NPI、GDS 评分比较

组别	例数	MMSE	ADAS-cog	ADL	NPI	GDS
对照组						
干预前	48	18.52 ± 3.40	28.96 ± 6.80	34.96 ± 6.80	13.52 ± 4.74	3.85 ± 0.77
干预 1 年后	48	20.33 ± 3.49 ¹⁾	25.92 ± 6.72 ¹⁾	32.04 ± 6.79 ¹⁾	11.21 ± 4.82 ¹⁾	3.48 ± 0.95 ¹⁾
研究组						
干预前	48	18.31 ± 3.63	29.38 ± 7.23	35.46 ± 7.46	13.90 ± 4.04	3.88 ± 0.82
干预 1 年后	46	22.08 ± 4.17 ^{2) 3)}	23.02 ± 6.15 ^{2) 3)}	28.65 ± 7.20 ^{2) 3)}	9.31 ± 3.67 ^{2) 3)}	3.00 ± 1.07 ^{2) 3)}

注:与干预前比较,¹⁾ $P < 0.05$,²⁾ $P < 0.01$;研究组与对照组之间在干预 1 年后比较,³⁾ $P < 0.05$

3 讨论

目前认为 AD 是一种进行性不可逆的疾病,是在脑老化基础上产生的神经退行性病变。AD 的病程通常呈渐进性,表现为持续进行性的智能衰退,行为和神经系统功能相继发生障碍^[9]。由于 AD 的确切病因至今尚未完全明了,因此还未找到真正有效的治疗方法,目前治疗目的是改善症状,阻止痴呆进一步发展,维持残存的脑功能,减少并发症^[9]。因此,AD 患者的康复护理显得尤其重要,根据 Lawton 老化的适应模式理论^[8],临床上出现了产生了几种不同的老年痴呆护理模式,如人-环境相互作用模式、心理社会模式、康复模式、减低紧张阈值模式等。全程康复护理干预模式,主要是通过各种不同的行为干预,如认知干预、记忆干预、行为干预、心理干预、安全干预、用药指导、社区-家庭护理干预等,在对 AD 患者进行全面认知功能训练的基础上,更侧重于干预患者受损

功能的个性化全程康复护理训练,保护患者残存功能,并尽量促进患者丧失功能的恢复。

AD 患者主要表现为以记忆障碍为主的多种功能障碍,抑制控制能力和定势转换能力的异常是早、中期 AD 患者执行功能中最易受损的部分^[9]。所有患者在研究前均已接受 3 个月以上稳定剂量的多奈哌齐治疗,该时间标准的应用可确保多奈哌齐药物疗效达到一个稳定状态。治疗过程中患者未使用抗精神药物,而且多奈哌齐剂量未发生变化,因此认知能力和精神行为症状的改善不是由药物作用所致。通过对 AD 患者全程康复护理干预后,比较研究组与对照组患者在治疗前及全程康复护理干预 1 年后认知能力、精神状况、日常生活能力的改善情况。从测评的结果来看,研究组 AD 患者的 MMSE、ADAS-cog、ADL、NPI、GDS 等量表评分均明显优于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),因此,全程康复护理

肠梗阻导管减压后行肠内营养治疗 梗阻性左半结直肠癌

蒋邦好 谢志荣 梁伟雄

【摘要】 目的 探讨术前经肛放置肠梗阻导管联合肠内营养对梗阻性左结直肠癌的治疗作用。**方法** 2009 年 6 月至 2011 年 9 月,对该院收治的梗阻性左结直肠癌患者 24 例实施经肛置入肠梗阻导管减压,减压成功后给予肠内营养,治疗 5~7 d 后实施手术。观察置管后第 24 小时、48 h 肠梗阻缓解率、净引流量(引出量-冲洗量)。检测入院时、术前 1 h 的血红蛋白、血清白蛋白、转铁蛋白、前白蛋白。**结果** 24 例患者中 15 例梗阻症状明显缓解,实施肠内营养后,术前 1 h 各项营养指标对比均有显著改善。**结论** 梗阻性左半结直肠癌经肛置入肠梗阻导管减压成功后实施肠内营养是可行的,可以改善患者的营养状况。

【关键词】 经肛型肠梗阻导管; 肠内营养; 左结癌; 直肠癌; 梗阻

Enteral nutrition in patients with obstructive left colon or rectal carcinomas following drainage with transanal tube for intestinal obstruction JIANG Ban-hao, XIE Zhi-rong, LIANG Wei-xiong. Department of General Surgery Panyu Central Hospital, Guangdong 511400, China

【Abstract】 Objective The aim of this study was to investigate the effects of enteral nutrition following drainage with transanal tube for intestinal obstruction on obstructive left colon or rectal carcinomas. **Methods** Forty-four left colon or rectal obstructive patients treated between June 2009 and September 2011 were decompressed by drainage with transanal tube, and enteral nutrition were performed after anesis of intestinal obstruction,. Operation was performed after five to seven days' treatment. Remission rates of colorectal obstruction, drainage measure at the time of 24 and 48 hours after drainage with transanal tube were observed. The hemoglobin, serum albumin, transferring, and prealbumin at the time of admission to hospital, 1 hour before operation were tested. **Results** Obstruction symptoms was alleviated in 15 of 24 patients, the nutritive index was ameliorated significantly. **Conclusion** Enteral nutrition is feasible in patients with obstructive left colon or rectal carcinomas after drainage with transanal tube. It can improve nutritional condition.

【Key words】 transanal tube for intestinal obstruction; enteral nutrition left colon carcinomas; rectal carcinomas; obstruction

梗阻性左结直肠癌是普外科的常见急腹症,传统的治疗方法急诊行结肠造瘘,分期手术。近些年来,国内外有学者将经肛型肠梗阻导管用于治疗癌性结直肠梗阻,效果良好。2009 年 6 月至 2011 年 9 月,我院对 24 例梗阻性左结直肠癌患者实施经肛置入肠梗阻导管减压,减压成功后给予肠内

营养,避免了急诊手术,行肠道准备后,大部分患者有条件实施一期切除吻合。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009 年 6 月至 2011 年 9 月,我院对 24 例梗阻性左结直肠癌患者实施经肛置入肠梗阻导管,其中男 15 例,女 9 例,年龄 37~81 岁,中位数 62 岁,1 例为降结肠癌,11 例为乙状结肠癌,12 例为直肠癌。

基金项目:广东省科技计划项目(项目编号:2010B031600188)

作者单位:511400 广东省番禺中心医院普外科

干预治疗 AD 患者具有较好的临床疗效,是一种有效的治疗方法。

参 考 文 献

- [1] 黄海华,李明秋,江皋轩,等. 卡拉汀治疗阿尔茨海默病的远期疗效观察. 中华老年心脑血管病杂志,2011,13(4):310-312.
- [2] 关青,王春艳,王利群,等. 多重干预对早中期老年性痴呆患者综合能力改善的影响. 中国老年学杂志,2009,29(7):1386-1387.
- [3] 贾建平. 临床痴呆病学. 北京大学医学出版社,2007:473-477.
- [4] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994:147-154.

sosition, 1994:147-154.

- [5] 聂莎,陈燕玲,杨航. 3R 强化护理对阿尔茨海默病患者生活质量的影响. 中华现代护理杂志,2011,17(15):1757-1759.
- [6] 马永兴,俞卓伟. 现代痴呆学. 科学技术文献出版社,2008:343-349.
- [7] 朱华倩,刘航,顾骏,等. 阿尔茨海默病动物模型的研究现状. 中国实用医药,2011,6(20):227-228.
- [8] Hall GR. Caring for people with Alzheimer's disease using the conceptual model of progressively lowered stress threshold in the clinical setting. Nurs Clin North Am, 1994, 29:129.
- [9] 刘淑文,周凤娟. 老年性痴呆的护理干预. 中国实用医药,2009,4(27):179-181.